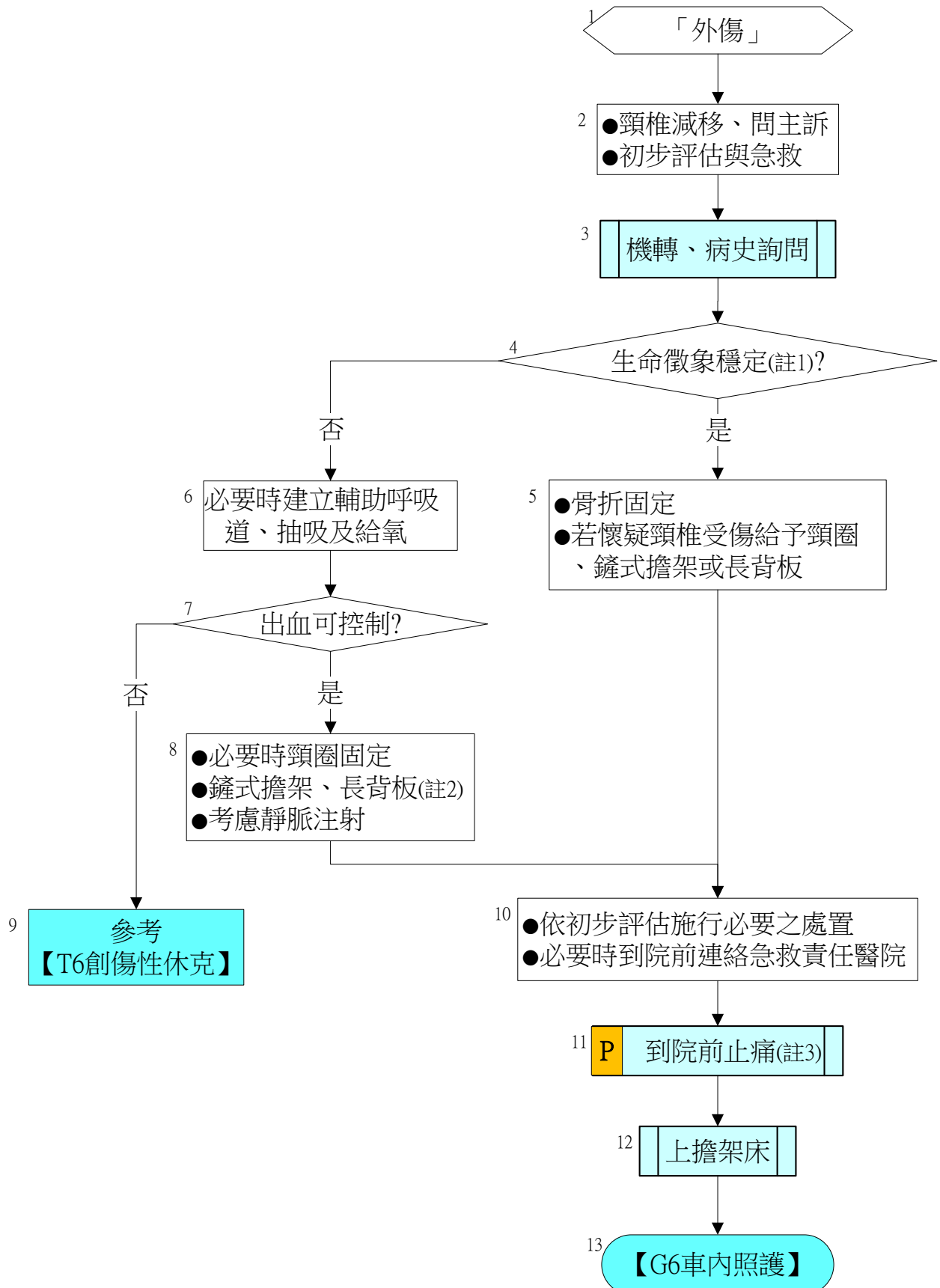


T5 肢體外傷

程 序



要 旨

- 一、肢體外傷常會造成傷患之疼痛與不安，故於搬運前應做好肢體之固定。
- 二、為避免傷患因持續出血而導致休克，控制可見的外出血為處置肢體外傷最重要的原則，並可考慮必要時予以輸液治療。
- 三、多處肢體外傷往往肇因於高能量撞擊，故應考量其合併胸、腹部外傷之可能性。

註 解

註1>

一、生命徵象不穩定指符合下列其中1項：

- (一) GCS<13
- (二) 呼吸 ≥ 30 次/分或 <10 次/分
- (三) 脈搏 ≥ 150 次/分或 <50 次/分
- (四) 收縮壓 <90 mmHg
- (五) SpO₂ $<90\%$
- (六) 體溫 $<32^{\circ}\text{C}$

二、觀察肢體是否有局部紅腫、變色、變形、撕裂傷、骨頭外露、或功能喪失。**開放性骨折之傷口應使用生理食鹽水濕潤的無菌紗布覆蓋。若骨頭末端已縮回傷口內，應在交接時主動告知醫護人員。**

三、外傷性截肢

- (一) 固定患肢末端並以乾燥無菌的敷料包裹殘肢。
- (二) 以無菌敷料包裹截肢肢體並浸潤於生理食鹽水中，將其放置在 1 個清潔塑膠袋，綁好後放入另 1 個裝有冰水的塑膠袋中。切勿直接放在冰塊上，切勿使用乾冰。在第 2 層的塑膠袋外標明傷患的名字及出生年月日及處置日期時間。
- (三) 將傷患及其截肢部位肢體一起後送。
- (四) 送醫時回報評估及已給予處置的過程，並迅速將傷患送往適當醫院。

註2>

生命徵象不穩定之多處肢體骨折可以考慮鑷式擔架(或長背板)協助固定，並儘速送醫。

註3> 參考單項技術【成人外傷到院前止痛】。